CAC
Cuenta de Alto Costo

5

Cáncer de colon y recto

RESUMEN infográfico

Cáncer de colon y recto

2 de enero de 2024 al 1° de enero de 2025

5

Morbimortalidad del cáncer de colon y recto



Ocupó el **tercer lugar**

en frecuencia entre los 11 tipos de cáncer priorizados, representando el 14,55 % de los casos nuevos reportados durante el periodo.



Se notificaron **4.893**

casos nuevos invasivos

lo que corresponde a una PCNR estandarizada de 8,05 casos nuevos por cada 100.000 habitantes (IC 95 %: 7,83 - 8,28).



Se registraron **3.989**

muertes entre las personas

con cáncer invasivo, lo que representa una mortalidad estandarizada de 6,35 por cada 100.000 habitantes (IC 95 %: 6,16 - 6,55).

El número total de casos nuevos, prevalentes y fallecidos en el periodo fue de 4.958, 48.238 y 4.020, respectivamente.

Caracterización de los casos nuevos de cáncer de colon y recto

La mediana de la edad fue de 66 años (RIC: 56 - 74).

El 52,84 % de los casos fueron en el sexo femenino.

El 21,88 % de los CNR fueron clasificados en estadio metastásico y el 38,53 % en estadio III, por lo tanto, más de la mitad de los casos nuevos de cáncer colorrectal se diagnosticaron en etapas localmente avanzadas.

Evaluación de la gestión del riesgo en los casos de cáncer de colon y recto

El indicador de detección temprana se ubicó en 30,66 %, levemente menor frente a 2024 (31,32 %).

En ninguno de los indicadores de oportunidad, se alcanzó la meta establecida

tanto a nivel nacional, **como en las regiones del país.**

Descargar infografía

PCNR: proporción de casos nuevos reportados.
IC: intervalo de confianza.
RIC: rango intercuartílico.
CNR: casos nuevos reportados.

5. Cáncer de colon y recto

CIE10: C18-C21, D01; CIE-O-3: C18-C21

5.1. Morbimortalidad del cáncer de colon y recto

Durante este periodo, el cáncer de colon y recto ocupó el tercer lugar entre las neoplasias con mayor número de casos nuevos reportados, con 4.958 casos, representó el 14,55 % del total de CNR de los tipos de cáncer priorizados, incluyendo los tumores *in situ* e invasivos. En términos de prevalencia, se registraron 48.238 casos, de los cuales el 97,71 % (n= 47.134) fueron de tipo invasivo. Además, se reportaron 4.020 muertes por todas las causas en los casos con este diagnóstico.

Este capítulo aborda de manera conjunta las neoplasias de colon, recto y canal anal. Durante el periodo analizado se notificaron 47.134 casos invasivos, de los cuales el 62,43 % (n= 29.427) correspondieron a cáncer de colon. En segundo lugar, se ubicó el cáncer de recto, con el 30,11 % (n= 14.190) de los casos, mientras que las neoplasias del canal anal representaron el 7,46 % (n= 3.517).

Enseguida, la **tabla 5.1** presenta las medidas de morbimortalidad estimadas, las cuales incluyen únicamente los casos invasivos.

Tabla 5.1. Medidas de frecuencia del cáncer de colon y recto en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Medida	Casos[1]	Medida cruda[2,3]	Medida estandarizada[2,4]	IC 95 %[5]
PCNR	4.893	9,30	8,05	(7,83 - 8,28)
Prevalencia	47.134	89,58	76,62	(75,93 - 77,32)
Mortalidad[6]	3.989	7,58	6,35	(6,16 - 6,55)

[1] Incluye todos los casos de cáncer de colon y recto invasivo, de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Informadas por cada 100.000 habitantes.
[3] La población de referencia corresponde a la proyectada por el DANE para el año 2024.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
[6] **Mortalidad general:** corresponde a los casos fallecidos por todas las causas, de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

5.1.1. PCNR de cáncer de colon y recto según la región y la entidad territorial

En Bogotá, D. C., se presentó la PCNR estandarizada más alta para esta neoplasia con más de 10 casos nuevos por 100.000 habitantes, mientras que en la región de Amazonía-Orinoquía fueron notificados cerca de 5 casos nuevos durante el 2025 **(tabla 5.2).** Estas medidas describen la ocurrencia de casos en las regiones analizadas y deben interpretarse en el contexto de las diferencias demográficas y de acceso a los servicios de salud.

En cuanto a las entidades territoriales, las cifras más elevadas correspondieron a residentes en Bogotá, D. C., (13,73), Risaralda (11,65) y Norte de Santander (9,57). En contraste, las más bajas se presentaron en Caquetá con 1,08 y Amazonas con 1,66 casos nuevos. En Guainía no se informaron casos nuevos durante el periodo.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 5.2. PCNR de cáncer de colon y recto según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	58	1.544.639	3,75	4,75	(3,60 - 6,13)
Bogotá, D. C.	1.310	7.918.660	16,54	13,73	(13,00 - 14,50)
Caribe	755	12.130.521	6,22	6,36	(5,91 - 6,83)
Central	1.201	12.486.760	9,62	7,53	(7,10 - 7,97)
Oriental	866	9.966.135	8,69	7,45	(6,96 - 7,97)
Pacífica	703	8.567.038	8,21	6,74	(6,24 - 7,26)
Nacional	**4.893**	**52.613.753**	**9,30**	**8,05**	**(7,83 - 8,28)**

[1] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de colon y recto invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La PCNR es informada por cada 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

5.1.2. PCNR de cáncer de colon y recto según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

Durante el 2025, la PCNR estandarizada más alta se presentó en el régimen contributivo con 8,86 casos por cada 100.000 afiliados. Por su parte la más baja correspondió al especial con 3,82 **(tabla 5.3).**

Entre las entidades aseguradoras de los regímenes contributivo y subsidiado, las mayores cifras se registraron en la EPS047, la EAS016 y la EAS027, con 202,60, 19,42 y 18,43, respectivamente. En contraste, los valores más bajos se identificaron en la ESS062, la EPSI03 y la EPSI06 con menos de un caso nuevo.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 5.3. PCNR de cáncer de colon y recto según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	3.266	28.511.097	11,46	8,86	(8,56 - 9,17)
Subsidiado	1.361	20.558.122	6,62	5,44	(5,15 - 5,74)
Excepción	254	2.096.836	12,11	7,34	(6,43 - 8,36)
Especial	11	40.687	27,04	3,82	(1,88 - 30,68)
No asegurado	1	SD	SD	SD	SD
Planes voluntarios de salud	0	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de colon y recto invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La PCNR es informada por cada 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada y los Planes voluntarios de salud, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de CNR.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

5.1.3. Prevalencia del cáncer de colon y recto según la región y la entidad territorial

Con respecto a las regiones, a excepción de Bogotá, D. C., la región Central registró la mayor prevalencia ajustada con 85,90 casos. Por su parte en la Amazonía-Orinoquía se presentó el valor más bajo con 39,52 casos **(tabla 5.4).**

De la misma manera que con la PCNR, Bogotá, D. C., y Risaralda presentaron las prevalencias más altas con 113,69 y 103,87 casos por cada 100.000 habitantes. En contraste, en los departamentos de Vichada y Guainía se observó el menor valor con menos de 10 casos.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 5.4. Prevalencia de cáncer de colon y recto según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	489	1.544.639	31,66	39,52	(36,08 - 43,20)
Bogotá, D. C.	10.894	7.918.660	137,57	113,69	(111,55 - 115,85)
Caribe	5.956	12.130.521	49,10	49,87	(48,61 - 51,16)
Central	13.902	12.486.760	111,33	85,90	(84,46 - 87,36)
Oriental	7.857	9.966.135	78,84	66,70	(65,23 - 68,20)
Pacífica	8.036	8.567.038	93,80	75,35	(73,69 - 77,04)
Nacional	**47.134**	**52.613.753**	**89,58**	**76,62**	**(75,93 - 77,32)**

[1] Incluye todos los casos de cáncer de colon y recto invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La prevalencia es informada por cada 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

5.1.4. Prevalencia del cáncer de colon y recto según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

La prevalencia estandarizada en el régimen contributivo fue 2,23 veces superior a la del subsidiado **(tabla 5.5).** Estas medidas describen la ocurrencia de casos en por régimen y para su análisis deben interpretarse en el contexto de las diferencias demográficas y de acceso a los servicios de salud.

Entre las entidades aseguradoras, la EPS047, la EAS027 y la EAS016 registraron los valores más altos con 202,60, 143,87 y 124,87 casos respectivamente. En contraste, las cifras más bajas correspondieron a la EPSI03 con 13,19 y la EPSI01 con 14,66.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 5.5. Prevalencia de cáncer de colon y recto según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	33.444	28.511.097	117,30	89,65	(88,69 - 90,62)
Subsidiado	10.218	20.558.122	49,70	40,14	(39,35 - 40,94)
Excepción	2.605	2.096.836	124,23	73,72	(70,82 - 76,73)
Especial	132	40.687	324,43	76,11	(59,57 - 106,82)
No asegurado	28	SD	SD	SD	SD
Planes voluntarios de salud	25	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	682	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos de cáncer de colon y recto invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La prevalencia es informada por cada 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de casos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

5.1.5. Mortalidad en las personas con cáncer de colon y recto según la región y la entidad territorial

En la cohorte en seguimiento, la mortalidad general estandarizada más alta se observó en Bogotá, D. C., seguida de la región Central, mientras que la cifra más baja se identificó en la región Amazonía-Orinoquía con 4,40 fallecidos por todas las causas por cada 100.000 habitantes **(tabla 5.6).**

Por lo que corresponde a los entes territoriales, las cifras más bajas se registraron en Chocó 1,45, Caquetá con 1,88 y Amazona con 2,02. Por su parte, las más altas se presentaron en Bogotá, D. C., y Risaralda con 9,18 y 8,55 muertes, en ese orden. En los departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada no se informaron defunciones por cualquier causa, lo cual es coherente con la baja prevalencia de este diagnóstico en estos departamentos. Específicamente, Guainía tuvo solo tres casos prevalentes y Vaupés junto con Vichada, presentaron siete cada uno.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 5.6. Mortalidad general de cáncer de colon y recto según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Muertes[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	53	1.544.639	3,43	4,40	(3,29 - 5,75)
Bogotá, D. C.	892	7.918.660	11,26	9,18	(8,59 - 9,81)
Caribe	624	12.130.521	5,14	5,17	(4,77 - 5,59)
Central	1.135	12.486.760	9,09	6,81	(6,42 - 7,23)
Oriental	627	9.966.135	6,29	5,26	(4,86 - 5,69)
Pacífica	658	8.567.038	7,68	5,97	(5,52 - 6,45)
Nacional	**3.989**	**52.613.753**	**7,58**	**6,35**	**(6,16 - 6,55)**

[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con cáncer de colon y recto invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La mortalidad es informada por cada 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

5.1.6. Mortalidad del cáncer de colon y recto según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

En cuanto a los fallecimientos por todas las causas en la cohorte de cáncer de colon y recto, se registró una tasa estandarizada significativamente más alta en el contributivo **(tabla 5.7).** En cuanto a las entidades aseguradoras, las cifras más altas se observaron en la EAS027, la EAS016 y la EPSS34 con 77,47, 12,79 y 10,37 muertes por 100.000 afiliados, en ese orden. Por su parte, las más bajas correspondieron a la EPSI01 y la EPSI03 con 2 y 12 defunciones, respectivamente. La EPS047, con dos casos prevalentes, no reportó fallecimientos durante el periodo.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 5.7. Mortalidad general del cáncer de colon y recto según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

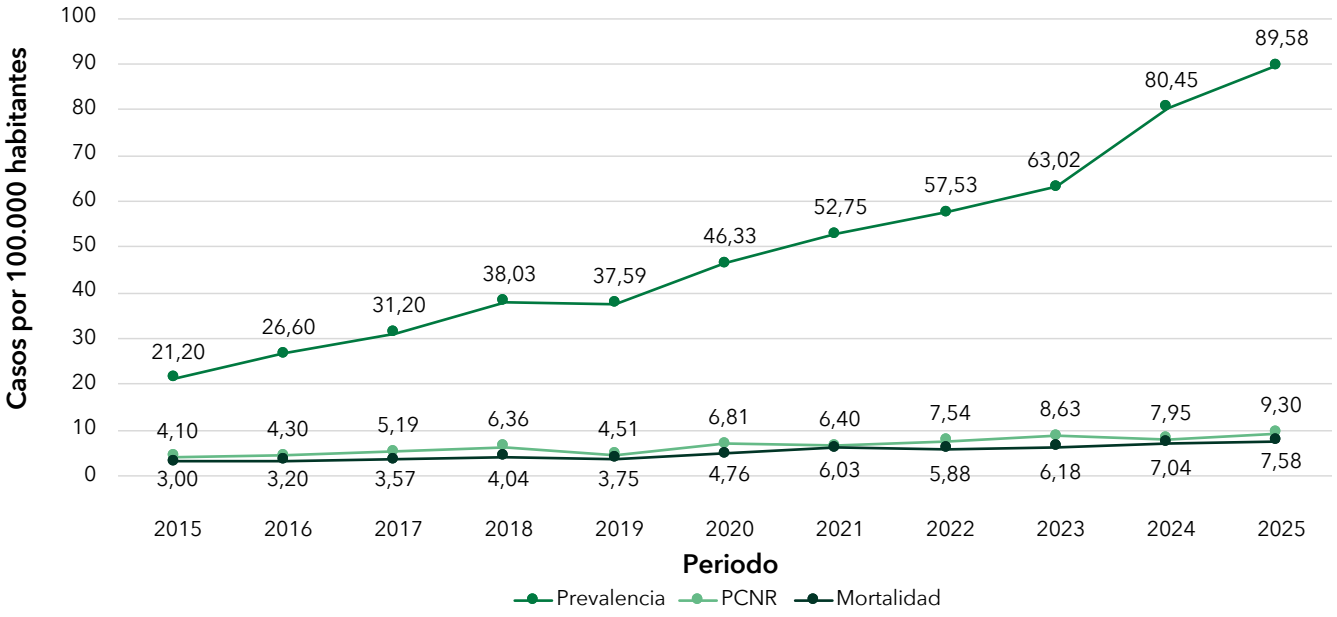
Régimen	Muertes[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	2.563	28.511.097	8,99	6,70	(6,44 - 6,97)
Subsidiado	1.179	20.558.122	5,73	4,49	(4,23 - 4,76)
Excepción	163	2.096.836	7,77	4,72	(3,99 - 5,56)
Especial	6	40.687	14,75	2,00	(0,71 - 29,58)
Planes voluntarios de salud	2	SD	SD	SD	SD
No asegurado	0	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	76	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con cáncer de colon y recto invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La mortalidad es informada por cada 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y en las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de fallecidos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

5.1.7. Evolución del registro de cáncer de colon y recto en el aseguramiento en Colombia

Durante los diez periodos de seguimiento, la cohorte de cáncer de colon y recto ha mostrado un aumento progresivo en el número de casos nuevos reportados. En el último periodo, la prevalencia aumentó en un 11,35 % con respecto al periodo anterior. Este comportamiento es consistente con la tendencia descrita a nivel internacional, donde los casos de esta neoplasia continúan en aumento como resultado de la mayor exposición a factores de riesgo y de una mejor detección de los casos (1). En el mundo, para el 2022 se estimaron cerca de 1,9 millones de casos nuevos y más de 900.000 muertes atribuibles a este tipo de tumor, lo que lo ubica como el tercer tipo de cáncer con mayor número de casos nuevos (2).

Figura 5.1. Tendencia de las medidas de frecuencia del cáncer de colon y recto en el marco del aseguramiento en Colombia, 2015 - 2025



Incluye los casos de cáncer de colon y recto invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
Las medidas presentadas corresponden a valores crudos, reportados por cada 100.000 habitantes.
Mortalidad: corresponde al número de casos fallecidos por todas las causas de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados.
Descargar figura

5.2. Caracterización de los casos nuevos de cáncer de colon y recto

5.2.1. Características sociodemográficas de los casos nuevos de cáncer de colon y recto

A continuación, la **tabla 5.8** presenta la caracterización general de los casos nuevos reportados de cáncer de colon y recto según el régimen del aseguramiento. En el país, el 66,94 % de los CNR estaba afiliado al régimen contributivo, más de la mitad fue diagnosticado en mujeres, la mediana de la edad fue de 66 años y el 51,36 % residía en la región Central o en Bogotá, D. C.

En relación con la distribución por grupos de edad, de los 4.958 casos nuevos reportados, el 4,68 % (n= 232) correspondió a personas menores de 40 años, el 9,62 % (n= 477) a personas entre 40 y 50 años y el 85,70 % (n= 4.249) a personas mayores de 50 años, lo que evidencia una concentración de la enfermedad en edades avanzadas.

Respecto al lugar de residencia, el 51,36 % de los casos residía en la región Central o en Bogotá, D. C., lo que indica una mayor concentración de los casos en estas áreas geográficas.

La mayoría de los casos de etnia negra se encontraban afiliados al régimen contributivo y la región con mayor concentración de CN en el subsidiado fue la región Caribe. Solo un caso en la población no asegurada fue diagnosticado en una mujer de 44 años, residente en la región Oriental.

Tabla 5.8. Caracterización sociodemográfica de los casos nuevos de cáncer de colon y recto reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento				Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	
	n= 3.319	n= 1.371	n= 255	n= 12	n= 4.958
	(66,94 %)	(27,65 %)	(5,14 %)	(0,24 %)	(100,00 %)
Sexo					
Femenino	1.710 (51,52)	765 (55,80)	137 (53,73)	7 (58,33)	2.620 (52,84)
Masculino	1.609 (48,48)	606 (44,20)	118 (46,27)	5 (41,67)	2.338 (47,16)
Edad	66 (56 - 74)	65 (55 - 74)	71 (60 - 78)	80 (74 - 84)	66 (56 - 74)
Etnia					
Ninguna	3.227 (97,23)	1.336 (97,45)	253 (99,22)	12 (100,00)	4.829 (97,40)
Negro	68 (2,05)	15 (1,09)	2 (0,78)	0 (0,00)	85 (1,71)
Indígena	5 (0,15)	19 (1,39)	0 (0,00)	0 (0,00)	24 (0,48)
Otro[3]	19 (0,57)	1 (0,07)	0 (0,00)	0 (0,00)	20 (0,40)
Región de residencia					
Amazonía-Orinoquía	8 (0,24)	45 (3,28)	7 (2,74)	0 (0,00)	60 (1,21)
Bogotá, D. C.	1.080 (32,54)	181 (13,20)	68 (26,67)	0 (0,00)	1.329 (26,81)
Caribe	304 (9,16)	441 (32,17)	21 (8,24)	0 (0,00)	766 (15,45)
Central	895 (26,97)	218 (15,90)	98 (38,43)	6 (50,00)	1.217 (24,55)
Oriental	564 (16,99)	253 (18,45)	56 (21,96)	1 (8,33)	875 (17,65)
Pacífica	468 (14,10)	233 (16,99)	5 (1,96)	5 (41,67)	711 (14,34)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad en la que se presenta la mediana (rango intercuartílico).
[2] Para los valores totales se tiene en cuenta un caso reportado como población no asegurada.
[3] Incluye población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, y palenquero de San Basilio.

5.2.2. Caracterización clínica de los casos nuevos reportados de cáncer de colon y recto

Según las características clínicas de los casos nuevos, el 98,69 % de los casos nuevos informados eran invasivos (de acuerdo con el código CIE-10) y la estadificación TNM se realizó en el 81,30 % (n= 4.031), proporción que ha venido aumentando en los últimos dos periodos. Según el régimen se observó un menor porcentaje de casos con estadificación en los regímenes subsidiado y de excepción, aunque con valores cercanos al cálculo nacional.

El 21,88 % de los CNR fueron clasificados en estadio metastásico y el 38,53 % en estadio III, por lo tanto, más de la mitad de los casos nuevos de cáncer colorrectal se diagnosticaron en etapas localmente avanzadas. Lo que sugiere dificultades de acceso a los programas de tamizaje. De los casos en estadio tempano I y de los casos *in situ* se reportaron con mayor frecuencia en el régimen contributivo.

Tabla 5.9. Caracterización clínica de los casos nuevos de cáncer de colon y recto reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento				Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	
	n= 3.319	n= 1.371	n= 255	n= 12	n= 4.958
	(66,94 %)	(27,65 %)	(5,14 %)	(0,24 %)	(100,00 %)
Extensión[3]					
In situ	53 (1,60)	10 (0,73)	1 (0,39)	1 (8,33)	65 (1,31)
Invasivo	3.266 (98,40)	1.361 (99,27)	254 (99,61)	11 (91,67)	4.893 (98,69)
Estadificación (sí)[4]	2.711 (81,68)	1.106 (80,67)	203 (79,61)	10 (83,33)	4.031 (81,30)
Estadio al diagnóstico[4,5]					
In situ	60 (2,21)	12 (1,08)	3 (1,48)	1 (10,00)	76 (1,88)
Estadio I	333 (12,28)	97 (8,77)	36 (17,73)	2 (20,00)	468 (11,61)
Estadio II	713 (26,30)	281 (25,41)	56 (27,59)	2 (20,00)	1.052 (26,10)
Estadio III	1.038 (38,29)	447 (40,42)	65 (32,02)	2 (20,00)	1.553 (38,53)
Estadio IV	567 (20,91)	269 (24,32)	43 (21,18)	3 (30,00)	882 (21,88)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables.
[2] Para los valores totales se tiene en cuenta un caso reportado de la población no asegurada.
[3] Definida según el código CIE-10.
[4] Definida según la clasificación TNM.
[5] Incluye todos los casos de cáncer de colon y recto que fueron estadificados.

5.2.3. Caracterización del tratamiento en los casos nuevos de cáncer de colon y recto

Durante el periodo, el 79,71 % (n= 3.952) de los casos nuevos recibió algún tipo de tratamiento. El tipo de tratamiento más frecuente fueron las terapias sistémicas con el 65,28 % (n= 2.580), seguidas de los procedimientos quirúrgicos con el 62,50 % (n= 2.470).

La **tabla 5.10** muestra la distribución de los tratamientos según el estadio clínico al momento del diagnóstico. Cerca del 90 % de los casos en estadios II y III recibió algún tipo de tratamiento. La cirugía fue la opción terapéutica de mayor frecuencia en los estadios I, II e *in situ*, mientras que la terapia sistémica representó la opción más usada en los estadios III y IV. Además, el 18,70 % de los casos con estadio desconocido, recibió algún tratamiento, el cual en su mayoría correspondió a tratamiento quirúrgico. La mayor frecuencia de uso de radioterapia se dio en los casos en estadio III.

Por otro lado, de los 1.006 casos nuevos que no recibieron tratamiento (20,21 %), el 32,11 % (n= 323) fueron diagnosticados en los tres meses previos al corte del periodo. Respecto a la estadificación, el 30,61 % (n= 308) se encontraba en estadios avanzados (III y IV), mientras que en el 46,62 % (n= 469) esta información era desconocida. Aunque estos casos no reportaron tratamientos con intención curativa, sí fueron valorados por cuidados paliativos.

Tabla 5.10. Frecuencia del tratamiento prescrito en los casos nuevos de cáncer de colon y recto según el estadio clínico en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Estadio al diagnóstico						Total
	In situ	Estadio I	Estadio II	Estadio III	Estadio IV	Desconocido	
	n= 76	n= 468	n= 1.052	n= 1.553	n= 882	n= 927	n= 4.958
	(1,53 %)	(9,44 %)	(21,22 %)	(31,32 %)	(17,79 %)	(18,70 %)	(100,00 %)
Casos que recibieron algún tratamiento	42 (55,26)	390 (83,33)	935 (88,88)	1.408 (90,66)	719 (81,52)	458 (49,41)	3.952 (79,71)
Tipo de tratamiento prescrito[2]							
Terapia sistémica[3]	0 (0,00)	102 (26,15)	565 (60,43)	1.132 (80,40)	616 (85,67)	165 (36,03)	2.580 (65,28)
Cirugía	40 (95,24)	323 (82,82)	682 (72,94)	832 (59,09)	267 (37,13)	326 (71,18)	2.470 (62,50)
Radioterapia	2 (4,76)	60 (15,38)	183 (19,57)	420 (29,83)	105 (14,60)	79 (17,25)	849 (21,48)

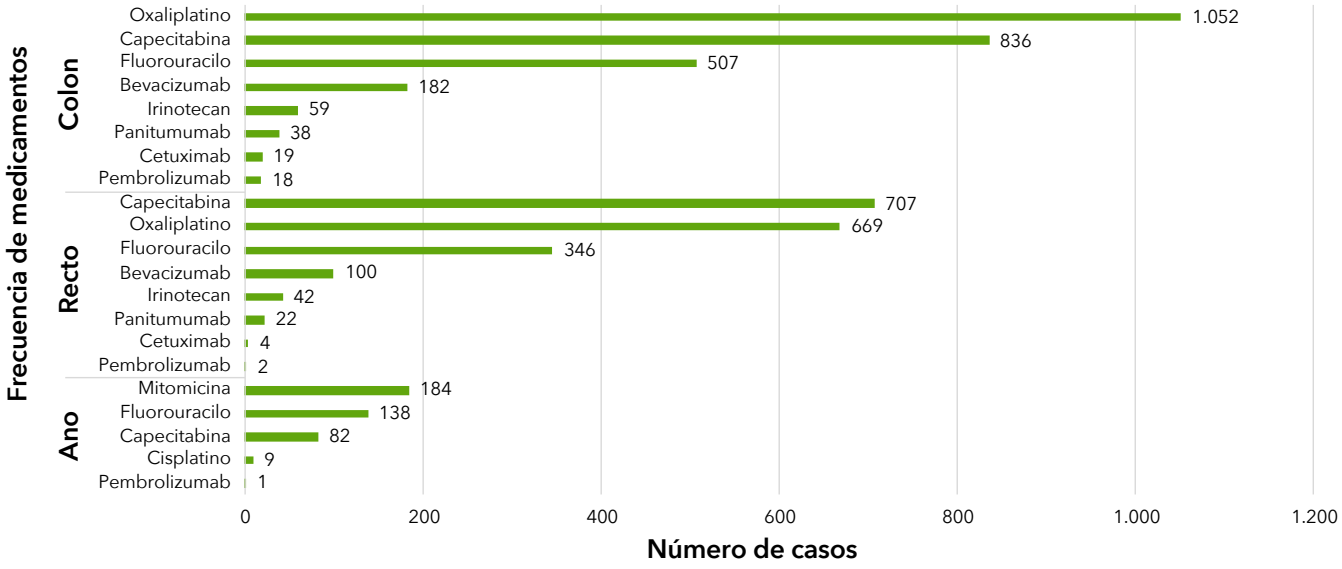
[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables.
[2] El tipo de tratamiento no es mutuamente excluyente, un mismo paciente pudo haber recibido más de un tipo de terapia.
[3] En este grupo se incluyen la quimioterapia y otras terapias sistémicas.

En la **figura 5.2** se presentan los medicamentos que fueron administrados con mayor frecuencia a los casos nuevos durante el periodo 2025. En los tumores de colon y recto, los esquemas de quimioterapia más utilizados incluyeron el oxaliplatino, la capecitabina y el fluorouracilo. En algunos casos, estos citotóxicos se combinaron con el bevacizumab o, con menor frecuencia, con el panitumumab. En los tumores de ano, los esquemas de elección incluyeron la mitomicina, el fluorouracilo y la capecitabina.

Por su parte, el pembrolizumab fue administrado en pacientes en las neoplasias de colon, recto y ano. Respecto al cáncer de ano, se identificó un caso en estadio IV que había recibido previamente tratamiento con mitomicina y fluorouracilo, y posteriormente recibió pembrolizumab en el contexto de enfermedad avanzada.

Es importante señalar que los datos reflejan el número absoluto de registros de medicamentos y no al número de pacientes, ya que no se consideró el uso concomitante de uno o más fármacos.

Figura 5.2. Distribución de los medicamentos prescritos con mayor frecuencia en los casos nuevos de cáncer de colon y recto en el marco del aseguramiento, Colombia 2025



Incluye cáncer *in situ* e invasivo en todas las edades.

Descargar figura

5.3. Caracterización de los casos prevalentes de cáncer de colon y recto

A continuación, en la **tabla 5.11,** se presenta la caracterización de los casos prevalentes de este tipo de cáncer reportados en el periodo según el régimen del aseguramiento. En este grupo, la mediana de la edad fue de 68 años y el 56,35 % correspondió al sexo femenino. Además, la mayoría de los casos estaban afiliados al régimen contributivo (72,06 %), cerca del 1,00 % pertenecía a la población afrodescendiente y la mayor proporción de casos, residía en la región Central.

En los regímenes de excepción, especial y los planes voluntarios de salud, la mediana de la edad alcanzó los 71 años o más, a diferencia de los demás grupos del aseguramiento, en los que se ubicó entre los 59 y los 68 años. Respecto a la distribución geográfica, los casos se concentraron principalmente en la región Central; sin embargo, en el subsidiado predominaron los residentes de la región Caribe, mientras que en la población no asegurada la mayor proporción se ubicó en la región Oriental.

Tabla 5.11. Caracterización sociodemográfica de los casos prevalentes de cáncer de colon y recto según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento						Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	Planes voluntarios de salud	No asegurado	
	n= 34.252	n= 10.430	n= 2.654	n= 140	n= 26	n= 29	n= 47.531
	(72,06 %)	(21,94 %)	(5,58 %)	(0,29 %)	(0,05 %)	(0,06 %)	(100,00 %)
Sexo							
Femenino	18.994 (55,45)	6.196 (59,41)	1.486 (55,99)	70 (50,00)	19 (73,08)	17 (58,62)	26.782 (56,35)
Masculino	15.258 (44,55)	4.234 (40,59)	1.168 (44,01)	70 (50,00)	7 (26,92)	12 (41,38)	20.749 (43,65)
Edad	68 (58 - 77)	66 (57 - 75)	71 (62 - 78)	76 (68 - 81)	72 (62 - 82)	59 (50 - 71)	68 (58 - 76)
Etnia							
Ninguna	33.862 (98,86)	10.154 (97,35)	2.589 (97,55)	140 (100,00)	26 (100,00)	29 (100,00)	46.800 (98,46)
Negro	319 (0,93)	104 (1,00)	60 (2,26)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	483 (1,02)
Indígena	25 (0,07)	164 (1,57)	3 (0,11)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	192 (0,40)
Otro[3]	46 (0,13)	8 (0,08)	2 (0,08)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	56 (0,12)
Región de residencia							
Amazonía-Orinoquía	161 (0,47)	297 (2,85)	41 (1,54)	0 (0,00)	1 (3,85)	0 (0,00)	500 (1,05)
Bogotá, D. C.	9.069 (26,48)	1.225 (11,74)	612 (23,06)	12 (8,57)	16 (61,54)	4 (13,79)	10.938 (23,01)
Caribe	2.787 (8,14)	2.717 (26,05)	474 (17,86)	7 (5,00)	3 (11,54)	1 (3,45)	5.989 (12,60)
Central	10.587 (30,91)	2.624 (25,16)	779 (29,35)	58 (41,43)	1 (3,85)	7 (24,14)	14.056 (29,57)
Oriental	5.560 (16,23)	1.817 (17,42)	518 (19,52)	24 (17,14)	2 (7,69)	16 (55,17)	7.937 (16,70)
Pacífica	6.088 (17,77)	1.750 (16,78)	230 (8,67)	39 (27,86)	3 (11,54)	1 (3,45)	8.111 (17,06)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad, para la que se presenta la mediana (rango intercuartílico).
[2] No se incluyen los datos de 707 casos prevalentes que no se reportaron en el periodo actual o que pertenecen a entidades liquidadas.
[3] Incluye población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, y palenquero de San Basilio.

5.4. Indicadores de la gestión del riesgo en cáncer de colon y recto

Los siguientes son los indicadores prioritarios para la medición, la evaluación y el monitoreo de la gestión del riesgo por parte de los aseguradores y de los prestadores en las personas con cáncer de colon y recto en Colombia (3):

1. Oportunidad de diagnóstico (promedio de días).
2. Proporción de pacientes con cáncer de colon y recto clasificado *in situ*.
3. Proporción de casos nuevos identificados en estadios tempranos.
4. Proporción de pacientes con estadificación por TNM.
5. Proporción de pacientes con diagnóstico de cáncer de recto con estadificación TNM antes del inicio del tratamiento.
6. Oportunidad de tratamiento (promedio de días).
7. Oportunidad entre la neoadyuvancia y la cirugía curativa en pacientes con cáncer de recto (promedio de días).
8. Oportunidad entre la cirugía y el inicio de adyuvancia (promedio de días).
9. Proporción de pacientes estadio I a III sometidos a cirugía como tratamiento curativo.
10. Oportunidad entre el inicio de tratamiento y el primer abordaje multidisciplinario (nutrición-psicología) (promedio de días).
11. Proporción de paciente con valoración por nutrición.

12.1. Proporción de pacientes sometidos a cirugía cuyo informe de patología indica número de ganglios examinados, número de ganglios positivos y estado de los márgenes, el tamaño del tumor y el grado histológico.

12.2. Proporción de pacientes sometidos a cirugía cuyo informe de patología indica doce o más ganglios resecados reportados.

13. Supervivencia a 5 años.
14. Tasa de mortalidad general.
15. Incidencia del cáncer de colon y recto.

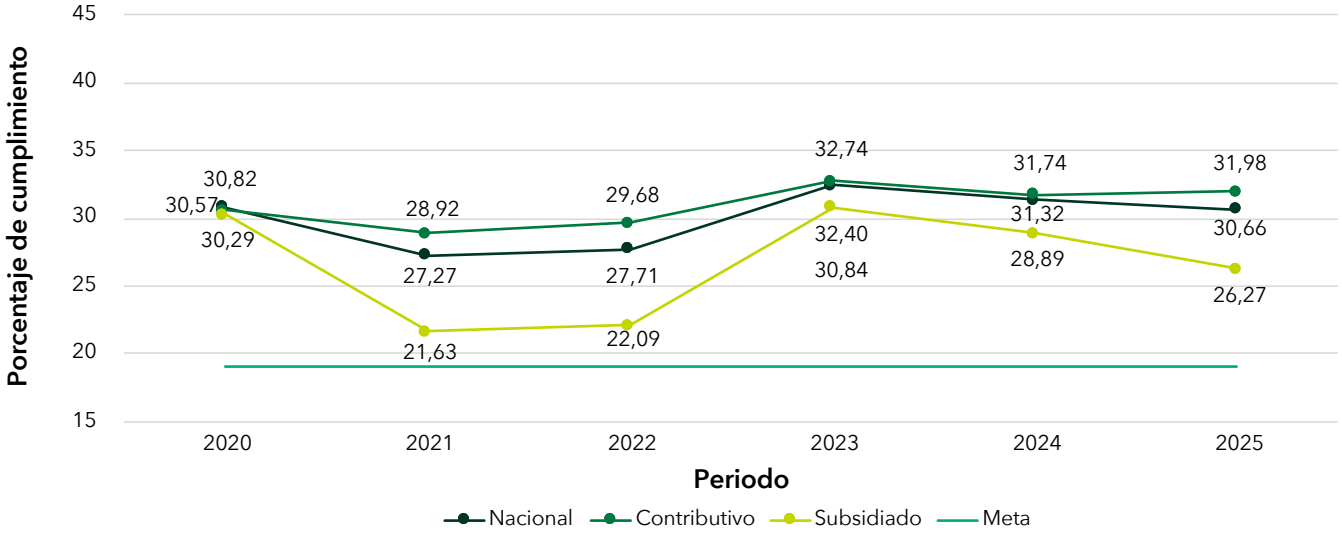
Es importante señalar que los resultados más recientes del indicador 13 se presentaron en el informe especial "Resultados de supervivencia global en las personas atendidas en el marco del sistema de salud colombiano y notificadas a la Cuenta de Alto Costo 2014 - 2022" (4). Por otra parte, los indicadores 14 y 15 se desarrollan en el apartado de morbimortalidad, ubicado al inicio del capítulo.

Puede consultar los datos de la gestión del riesgo con una mayor desagregación ingresando a HIGIA.

La **figura 5.3** presenta la tendencia de la detección temprana de cáncer de colon y recto en el país según el régimen del aseguramiento. Durante los dos últimos periodos se observó una disminución en la proporción de casos diagnosticados en estadios tempranos; no obstante, el resultado nacional del último periodo se mantuvo por encima de la meta definida para el indicador (> 19 %). Este comportamiento resalta la importancia de continuar fortaleciendo las acciones orientadas al diagnóstico en estadios tempranos, en línea con los objetivos del Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia.

Particularmente, en el régimen subsidiado se observó una tendencia decreciente, con resultados por debajo del valor nacional, mientras que el régimen contributivo presentó un comportamiento más favorable, con proporciones superiores a las del país. Estas diferencias entre regímenes son coherentes con los hallazgos observados en la oportunidad diagnóstica y señalan la necesidad de mantener el seguimiento diferencial de este indicador, con el fin de orientar acciones que favorezcan el diagnóstico oportuno en todos los grupos de afiliación.

Figura 5.3. Tendencia de la proporción de pacientes con cáncer de colon y recto identificados en estadios tempranos (I a IIa) en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 - 2025



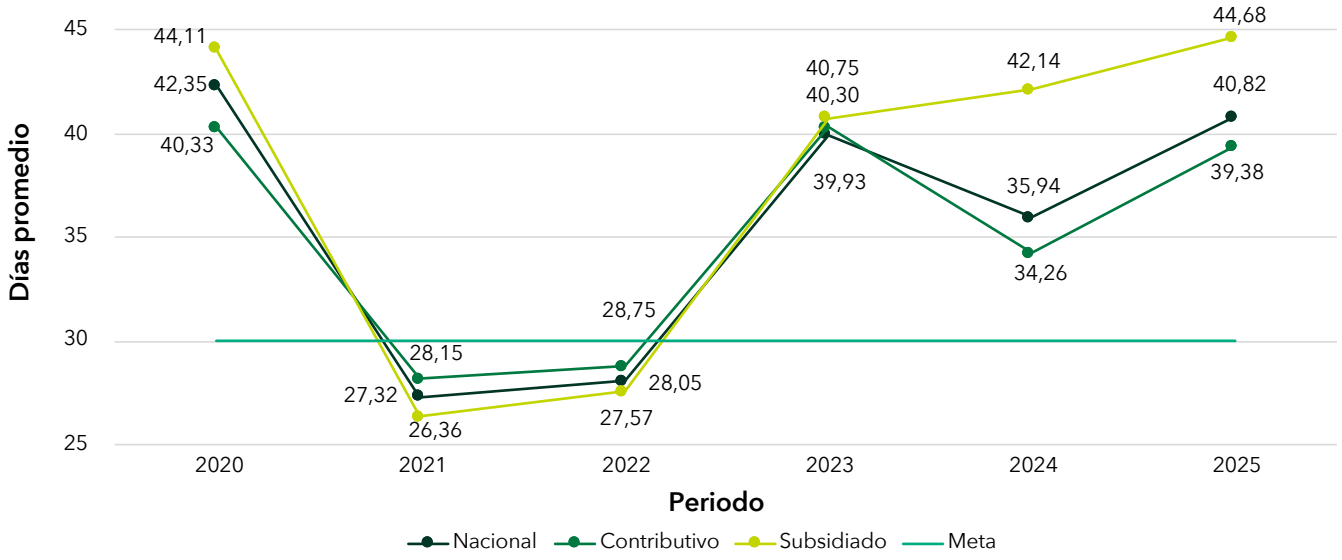
Detección temprana: incluye estadios I a IIa.

Descargar figura

Para 2025, se observó un incremento en el tiempo de espera para la confirmación diagnóstica del cáncer de colon y recto tanto en el país como en los regímenes contributivo y subsidiado, manteniendo la tendencia ascendente identificada desde 2022. En contraste, entre 2021 y 2022 se evidenció una reducción de este indicador. Aunque se observa una reducción la brecha entre ambos regímenes con respecto al periodo anterior, los resultados del indicador se mantuvieron en un nivel de desempeño intermedio. Específicamente, en el régimen subsidiado, el tiempo de espera continuó siendo mayor que en el contributivo (con una diferencia cercana a cinco días), lo que corresponde al valor más alto registrado en los últimos cinco periodos. Este resultado resalta la importancia de fortalecer las acciones orientadas a mejorar la oportunidad de la confirmación diagnóstica.

En el contexto internacional, las demoras diagnósticas en el cáncer colorrectal han sido mayores en las poblaciones con condiciones socioeconómicas más desfavorables o con una mayor vulnerabilidad social (5). Asimismo, la evidencia señala que uno de los principales componentes de esta demora corresponde al intervalo entre la sospecha clínica y la confirmación diagnóstica, particularmente concretamente por dificultades en el acceso oportuno a procedimientos como la colonoscopia y la biopsia (6), factores que podrían estar influyendo en la situación del país.

Figura 5.4. Tendencia de la oportunidad de la confirmación diagnóstica en los casos nuevos de cáncer de colon y recto en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 - 2025



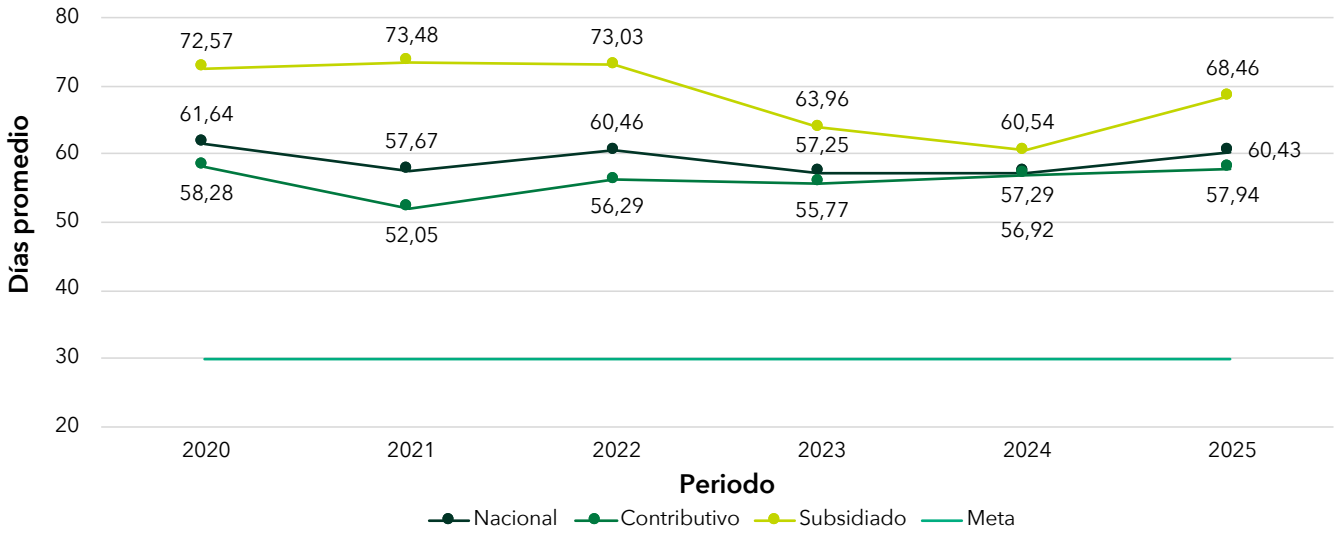
Incluye cáncer *in situ* e invasivo.
Oportunidad diagnóstica: tiempo transcurrido desde la consulta o la remisión hasta la confirmación diagnóstica.
La media (desviación estándar) para la oportunidad del diagnóstico en el 2025 fue: de 40,82 días (± 62,70) en la medición nacional, de 39,38 días (± 60,03) en el régimen contributivo y de 44,68 días (± 69,40) en el subsidiado.
La mediana (rango intercuartílico) para la oportunidad del diagnóstico en el 2025 fue: de 20 días (RIC: 10 - 46) en la medición nacional, de 19 días (RIC: 10 - 45) en el régimen contributivo y de 22 días (RIC: 10 - 50) en el subsidiado.

Descargar figura

En cuanto a la oportunidad de inicio del tratamiento, los tiempos de espera aumentaron con respecto al periodo previo. Sin embargo, se mantuvieron por debajo de los valores observados en 2020. Por otra parte, el menor tiempo promedio para el inicio del tratamiento durante la serie analizada se registró en 2021, tanto en el país como en el régimen contributivo. Este comportamiento coincide con el periodo de la pandemia por COVID-19, sin que esto permita establecer una relación directa.

Durante los últimos seis periodos, el régimen contributivo presentó tiempos de acceso al tratamiento más cortos, en comparación con el subsidiado, lo que evidencia una brecha persistente entre ambos regímenes. Sin embargo, estos lapsos son de más de 30 días de espera, lo que evidencia la necesidad de implementar nuevas estrategias o fortalecer las existentes para mejorar la oportunidad en el inicio del tratamiento una vez confirmado el diagnóstico **(figura 5.5).**

Figura 5.5. Tendencia de la oportunidad del inicio del tratamiento de los casos nuevos de cáncer de colon y recto en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 – 2025



Incluye cáncer *in situ* e invasivo.
Oportunidad de tratamiento: tiempo entre el diagnóstico histológico y el primer tratamiento.
La media (desviación estándar) para la oportunidad del tratamiento en el 2025 fue: de 60,43 días (± 49,60) en la medición nacional, de 57,94 días (± 45,46) en el régimen contributivo y de 68,46 días (± 58,79) en el subsidiado.
La mediana (rango intercuartílico) para la oportunidad del tratamiento en el 2025 fue: de 49 días (RIC: 25 - 82) en la medición nacional, de 48 días (RIC: 27 - 78) en el régimen contributivo y de 54,50 días (RIC: 23 - 95) en el subsidiado.

Descargar figura

Finalmente, la **tabla 5.12** presenta el comportamiento de los indicadores por región. En todos los territorios del país, la detección temprana se mantuvo por encima del 20 %. En comparación con el periodo anterior, la proporción de casos *in situ* disminuyó en la mayoría de las regiones, con excepción de Amazonía-Orinoquía. Por su parte, la estadificación al momento del diagnóstico se realizó en el 80,00 % o más en la mayoría de las regiones, aunque el menor resultado se registró en la Oriental. Aun así, el porcentaje de casos en los que se conoció el estadio antes de iniciar el tratamiento fue menor (64,86 %), lo que podría implicar que algunos pacientes iniciaron tratamiento sin contar con una caracterización clínica completa de la neoplasia. Esta situación podría incidir en un direccionamiento inadecuado de las alternativas terapéuticas con intención curativa, especialmente en las regiones Caribe y Amazonía-Orinoquía, donde este resultado fue inferior al 60 %.

Por otra parte, uno de los avances más relevantes en el país, especialmente en las regiones Caribe, Central y Bogotá, D. C., fue el aumento en la valoración nutricional, que se incrementó en un 18,64 % con respecto a 2024. Este hallazgo es de especial importancia en el marco del tratamiento del cáncer de colon y recto, dado que la malnutrición y el riesgo nutricional en este tipo de cáncer se asocian con peores desenlaces clínicos, mayor toxicidad, menor tolerancia a los tratamientos y más complicaciones en el contexto quirúrgico. En este sentido, fortalecer la identificación temprana del riesgo y el soporte nutricional oportuno constituye un componente relevante de la atención integral, particularmente en neoplasias como esta, en las que son frecuentes los procedimientos quirúrgicos y los tratamientos sistémicos (7).

Tabla 5.12. Indicadores de gestión del riesgo en cáncer de colon y recto según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Número		1.	2.	3.	4.	5.	6.
Código[1]		COL_01	COL_02	COL_03	COL_04	COL_05	COL_06
Semaforización		< 30 días	> 3,6 %	> 19 %	> 90 %	> 90 %	< 30 días
		30 a < 60 días	> 2,2 a 3,6 %	> 15 a 19 %	> 60 a 90 %	> 60 a 90 %	30 a < 60 días
		≥ 60 días	≤ 2,2 %	≤ 15 %	≤ 60 %	≤ 60 %	≥ 60 días
Región	Amazonía-Orinoquía	32,31	3,92	24,49	85,00	57,14	46,11
	Bogotá, D. C.	39,03	2,06	30,85	80,26	63,02	60,74
	Caribe	44,27	2,11	31,79	80,55	57,14	53,30
	Central	40,66	1,88	31,90	87,43	70,32	54,93
	Oriental	39,76	1,45	29,52	78,88	68,59	69,51
	Pacífica	42,96	1,58	28,70	80,17	61,68	69,06
Nacional		**40,82**	**1,87**	**30,66**	**81,86**	**64,86**	**60,43**

Tabla 5.12. Indicadores de gestión del riesgo en cáncer de colon y recto según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025 (continuación)

Número		7.	8.	9.	10.	11.	12.1.	12.2.
Código[1]		COL_07	COL_08	COL_09	COL_10	COL_11	COL_12_1	COL_12_2
Semaforización		56 a 83 días	≤ 55 días	> 90 %	Por definir	> 90 %	Por definir	Por definir
				> 60 a 90 %		> 60 a 90 %		
		> 84 días	> 56 días	≤ 60 %		≤ 60 %		
Región	Amazonía-Orinoquía	SD	86,63	41,18	53,00	33,33	31,58	73,68
	Bogotá, D. C.	128,75	60,82	58,20	57,75	40,84	37,94	56,57
	Caribe	144,75	59,03	55,85	47,36	55,48	37,64	43,39
	Central	211,17	64,68	58,10	61,62	41,74	51,53	61,19
	Oriental	169,50	69,58	49,91	54,63	28,42	49,85	60,12
	Pacífica	186,00	67,71	53,67	54,21	36,43	42,72	52,43
Nacional		**186,79**	**64,16**	**55,57**	**55,90**	**40,41**	**43,98**	**55,84**

[1] Código del indicador en HIGIA.
SD: sin dato.

Referencias bibliográficas

1. Sung H, Siegel R, Laversanne M et al. Colorectal cancer incidence trends in younger versus older adults: an analysis of population-based cancer registry data. The Lancet Oncology, 2024; 26, 51-63.

2. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Disponible en: https://gco.iarc.who.int/today, consultado en abril de 2026

3. Cuenta de Alto Costo. Consenso basado en evidencia. Indicadores de gestión del riesgo en pacientes con cáncer gástrico y cáncer de colon y recto en Colombia [en línea]. 2017. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/publicaciones/consenso-basado-en-evidencia-indicadores-de-gestion-del-riesgo-en-pacientes-con-cancer-gastrico-y-cancer-de-colon-y-recto-en-colombia/

4. Cuenta de Alto Costo (CAC), Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Informe especial: Resultados de supervivencia global en las personas atendidas en el marco del sistema de salud colombiano y notificadas a la Cuenta de Alto Costo, 2014 - 2022; Bogotá, D. C. 2025. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/publicaciones/informe-de-supervivencia-2014-2022/

5. Davis LE, Strumpf EC, Patel SV, Mahar AL. Income differences in time to colon cancer diagnosis. Cancer Med. 2024 Aug;13(15):e6999. doi: 10.1002/cam4.6999. PMID: 39096087; PMCID: PMC11297540.

6. Roubin, Samuel and Yoerg, Broderick and Desjardins, Michael R., Geographic Access to Colonoscopy, Neighborhood Social Vulnerability, and Associations with Late-Stage Colorectal Cancers in Maryland: 2010 - 2023. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=5276281 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5276281

7. Muscaritoli M, Arends J, Bachmann P, ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer Clinical Nutrition, 2021; 40, 2898-2913.